Sujet n°220 : Prise en charge d'une hyperlymphocytose

Spécialité : Hématologie

Date : 27/09/2023

Auteur : Dr Debureaux
Relecteur(s) : Pr Perrot et Dr Talbot, Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Examen clinique
Item(s) en lien avec la station	Item 212 - Hémogramme Item 315 - LLC
Situation(s) de départ en lien avec la station	220- Prise en charge d'une hyperlymphocytose
Matériel nécessaire à la station	Un patient simulé
Contexte de la station	Consultation médicale

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes remplaçant d'un médecin généraliste. Vous recevez Monsieur J.B., 72 ans, venant pour une consultation de suivi annuelle à votre cabinet de remplacement.

Il est asymptomatique.

Il vous tend sa prise de sang faite en début de semaine dont voici les principaux résultats :
Leucocytes 14,6 G/L dont PNN 4 G/L, Monocytes 0,5 G/L, PN basophiles 0,01 G/L, PN éosinophile 0,1 G/L, Lymphocytes 10 G/L. Frottis sanguin : Lymphocytes de petite taille. Hémoglobine 14 g/dL, Plaq 250 G/L.
Créatinine 50 µmol/L, bilan hépatique normal. LDH 200 UI/L (norme < 500 UI/L)

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :
- Réaliser l'interrogatoire du patient
- Enoncer les éléments à rechercher, en justifiant et en énonçant votre technique clinique, à l'examen clinique dans ce contexte

Vous ne devez pas :
- Enoncer la prise en charge de ce patient
- Réaliser de prescription

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D’EVALUATION

Aptitudes cliniques (max 15 items)	
INTERROGATOIRE	
Rechercher un épisode infectieux (contage)	1 pt
Rechercher antériorité de la NFS (fournir le bilan précédent si demandé)	1 pt
ATCD médicaux personnel et familiaux avec focus sur le cancer	1 pt
Recherche de signes B (sueurs profuses, fièvre vespérale ou perte de 10% du poids en 6 mois)	1 pt
Recherche de signe de compression (circulation veineuse collatérale thoracique), pesanteur abdominale (interrogatoire et clinique)	1 pt
EXAMEN PHYSIQUE (on donne les points si l'examen est justifié, par ex auscultation cardiaque réalisée sans explication = 0).	
Prise de température (recherche de fièvre)	1 pt
Recherche adénomégalie en *se plaçant derrière le patient pour la palpation cervicale*	1 pt
Recherche des adénomégalies au niveau : - inguinal - axillaire - cervical	1 pt si 3/3
Recherche hépato-splénomégalie, *examen abdominal en se mettant à gauche pour le foie et à droite pour la rate*	1 pt
Examen buccal : angine ? bulles ? mycose ? (angine pour hémopathie, mycose pour atteinte immunitaire)	1 pt si 1 des 3
Auscultation cardio-pulmonaire (recherche d'épanchement pleural, souffle cardiaque en faveur d'une infection)	1 pt
Recherche d'un signe du godet au niveau des membres inférieurs	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)	

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

1 pt☐

Réassurer le patient sur l'anomalie sanguine

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

1 pt ☐

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

1 pt☐

TOTAL (max 20 items)	**Sur 20 points**

<u>Consigne(s) à l'évaluateur :</u>ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Hyperlymphocytose lors d'un bilan systématique (bilan annuel)

Plan de la station ECOS :

Ou se positionne le patient simulé ?

Assis devant un bureau (consultation médicale)

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Expliquer les résultats de ma prise de sang

Identité du patient :

Jean Bernard, 72 ans, Homme, 1m80, 75kg

Mode de vie :

Allergies :

- aucune

Vaccins :

- à jour dont la coqueluche à 65 ans (cocooning pour les petits enfants)

Habitus :

- Vit à domicile, marié. 2 petits enfants
- A la retraite, chef de chantier dans le BTP.
- Pas d'alcool, tabac à l'armée puis arrêt il y a 50 ans

Comportement global :

Inquiet par les chiffres rouges sur la prise de sang fait pour un bilan de routine annuel alors qu'il se sent très bien

Antécédents personnels :

Antécédents :

- Médicaux : aucun
- Chirurgicaux : amygdalectomie à 10 ans

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

Aucun

Symptômes positifs :

Examen clinique normal (pas de syndrome tumoral)

Constantes :

- TA 120/80 mmHg
- Fréquence cardiaque 90 bpm

- Saturation périphérique en O2 99%
- Fréquence respiratoire 14/min
- T 36.5°C

Donnée complémentaire :

Prise de sang antérieure il y a 1 an
Leucocytes 10 G/L dont PNN 4 G/L, Monocytes 0,5 G/L, PNbasophiles 0,01 G/L, PN eosinophile 0,1 G/L, Lymphocytes 5,5 G/L.

Questions de relance :

- Est-ce grave docteur ? (si plusieurs fois la demande sur les symptômes malgré un patient asymptomatique)
- Est-ce que je dois aller à l'hôpital ? (au bout de 6 minutes de scénario)